

문서 분석 → 적용 지도 (본로이)

08 정책(종합계획·시행계획) · 06 통계(2024 유치실적) · 07 시장(러·CIS 보건산업 420p) · 01 규제(통합고시) · 법무부 우수기관 문서를 전문 정독해 캐낸 사실을, 어디에 어떻게 쓸지로 매핑한 것. 작성 2026-07-15. 수치는 전부 원문 근거 있음(페이지 표기).
※ 인용 주의: 문서 어디에도 "본로이" 실명·개별 유치업체 실적은 없음. 06(2024)과 07(2023)은 연도가 달라 수치가 다름 → 인용 시 연도·출처 명기. 암 카운트도 06 "암 레지스트리 1,530명"과 07 "신생물 C00-D48 2,469명"은 정의가 달라 혼용 금지.

전제(현 상태): 본로이는 2026년 KHIDI ICT 외국인환자 사전·사후관리 사업의 수행기관(협약 8,750만원, 04.06~11.20)이며 8/27이 이 사업의 중간평가다. 아래 ⑤ ICT 관련 내용은 "신청·지원"이 아니라 "지금 수행 중인 사업의 국가 맥락·규칙·경쟁·상대비교"로 읽을 것.

한 줄 결론

타겟 우선순위 = 카자흐스탄 > 러시아 > 우즈베키스탄. 그리고 정부가 지금 "중증·복합질환 + CIS"에 돈을 붓고 있어서, 본로이의 니치가 국가 정책 방향과 정확히 겹친다. 총량(201만) 경쟁이 아니라 "고부가 중증 세그먼트의 CIS 전문 유치업자"로 포지셔닝하는 게 전부다.

■ 즉시 액션 (지금 움직일 것)

- ⑤ ICT 사전·사후관리 사업 = 본로이가 지금 수행 중인 그 사업이다 (신규 지원 대상 아님). 본로이는 2026년 이 사업 수행기관(협약 8,750만원, 04.06~11.20)이고 8/27이 이 사업의 중간평가다. "2026년부터 유치사업자도 주관기관 가능"이 곧 본로이가 들어온 근거. → 지금 행길 것: ① 2025 선배 수행기관과 상대비교 — 원광대병원(몽골·카자흐) 상담 131건·유치 67명, 4곳 합계 상담 634건·유치 212명이 8/27 비교 밴드(시행계획 p66). ② 7월 중간점검·회계 관리감독 강화가 지금 적용되는 규칙(p67) → 정산·증빙 정비. ③ 지표(유치 12건·사후관리 120건·만족도 90)가 이 사업의 평가 기준.
- 법무부 우수유치기관 실적 축적 시작 — 자격 = 등록+사업개시 1년+초청 50건 or 진료 500건. 지금 실적이 문턱. 배점의 60%가 불법체류율이므로 초청 환자 정상귀국 관리를 처음부터 설계. 지정되면 전자비자 3일·간병인 4촌까지·재정입증 생략 = 암환자+보호자 유치의 결정적 무기. (법무부 붙임1)
- 러시아·CIS 민관협의체(2025.11.18 발족)에 편입 시도 — "CIS 적합 모델=연수·컨설팅·검진·사후관리 중심"이 본로이 역량과 일치. 진흥원 통해 이해관계자 진입. (시행계획 p54-57)
- ISO 9001 인증지원 사업 신청 — 무료 지원(2025 시범 4곳 전원 취득). 병원 상대 신뢰자산 → 이대서울 정식계약 협상 카드. (시행계획 p18-19-97)

A. 중간평가 (8/27) — 정성·정량 근거

발견 | 근거 | 어떻게 쓰나

카자흐=방한 암환자 1위 1,530명(+34.6%), 러 970명(4위). 카자흐+러=암환자의 35% | 06 표2.24 p28 | "타겟 시장의 성장·정합성" 정량 입증(표지 통계)

중증암환자 중 50%가 러시아·CIS / CIS 유치증가율 1위(카자흐 59.2%) | 종합계획 p81 | 니치가 국가 최우선 방향과 일치

정부 만족도 국가 평균 90.73점(23~25) | 시행계획 p97 | 본로이 만족도 목표 90점의 기준선

사전상담·사후관리 공식 정의·집계단위 | 종합계획 p52-55-56 | 대시보드 라벨·산정기준을 이 정의에 정렬

개인 유치업 회소(경유환자 법인 90.2% vs 개인 9.8%) | 06 표4.4 p148 | 개인 유치업 실적의 상대적 회소성

양·한방 협진 = 국가 인증 배점 0회(128항목 중) | 한의과 평가기준 | ※ 협진은 정성 서사·차별화요만. "점수 받는다"는 논리 금지

B. 제안서·영업 (병원·에이전사·투자 설득)

- "왜 한국인가": 한국 5년 암 상대생존율 세계최고(유방 93.2%-위 76.5%-대장 75%). (종합계획 p36)
- "왜 CIS인가": 러시아 말기암 진료거부→이스라엘 후송, 오진율 25~30%. 카자흐 진단장비 한국의 1/36(MRI 1.1 vs 39.3/100만명). (07 p39-p287)
- "왜 유치업자(본로이)인가": CIS는 유치사업자 의존도가 일본의 1.6~1.8배 — 러 36.7%-카 40.9%가 유치업 경유(일본 22.8%). (06 표4.2 p147)
- "카자흐는 뷰티가 아니다": 카자흐 방한환자 상급종합 46.5%(전 국가 최고), 내과·검진 중심(피부과 4.0%). (07 p298 / 06 표3.55)
- 시장 성장: 글로벌 의료관광 '25 435억→'35 2,926억달러(연 21%). (시행계획 p24)
- 경쟁 지형: 씨젠의료재단이 알마티에 한국형 사후관리 거점 이미 운영 → 협력 또는 차별화. (시행계획 p13-41)
- 여백: 우수기관 90곳 중 CIS·암 특화 유치업자는 사실상 공백(성형·피부 편중). 유치업자 18곳 지정 = 트랙은 열려 있음. (법무부 보도자료)

C. 계약·법무·컴플라이언스

- 수수료 상한(하드): 상급종합 15%-종합/병원 20%-의원 30%. 대학병원 협진=15% 천장. 통역·숙박비는 수수료에 못 씌움(별도청구). (통합고시 제2-3조)
- 레드라인: 과도수수료·명의대여·미등록유치·거짓정보=신고포상 대상(벌금의 30% 포상). (통합고시 제6장)
- 2025-72호 개정: 수수료·진료비 실태조사 협조 의무 신설(제4조), '26 하반기 실시 → 수수료 산정근거 상시 보관. 조문번호 +1 밀림(구 제32조→33조). (통합고시 개정)

- 신고제 확대: 상법상 회사(MSO 등)도 편입, 실적보고에 유치방법·알선여부 포함 의무('26.5 시행) → 케이스 경로 기록 강화. (시행계획 p17-91)
- 우수기관 기록의무: 사증신청-예약병원-실제진료병원 일치 자료 유지, 허위 시 처벌. (법무부 2025-306호)

D. 제품·로드맵 (HEALO)

- 비대면 협진 법제화(법 제21693호, 시행 2027-05): HEALO 원격협진의 최초 법적근거. 진료주체=유치의료기관, HEALO=비대면진료지원시스템 위탁·유치업자 포지션. 하위법령(신원확인·처방·기록)이 나오면 제품이 맞춰야 함 → 입법예고 모니터링. (08 미시행본 + 시행계획 p67)
- 정부가 유사 플랫폼을 직접 그림: K-헬스케어 통합허브 ISP('26, 4억) = 비대면진료~사후관리~결제~관광 전주기. 경쟁이자 연동 대상 → "정부 허브의 유치·사후관리 실행 파트너" 선점. (시행계획 p67-68)
- 규제 청신호(현지): 한·우즈벡 의료면허 상호인정(2015) — 한국 면허로 현지 진료 가능. 카자흐 법개정으로 의사-환자 비대면 허용. (07 p203-p310)
- 규제 주의(러시아): 러 원격의료법은 최초진료 비대면 진단·처방 금지(대면 선행) → HEALO를 "여행 전 사전상담·2차소견"으로 포지셔닝하면 저촉 회피. (07 p52)
- 디지털헬스 별도 재원: 원격협진이 "디지털헬스 해외진출 실증지원"(예산 2.4배 ↑)으로도 지원 가능. (시행계획 p35-63)
- 언어전략: 정부 공식 CIS 채널은 러시아어 중심, 카자흐어는 정부도 미포함 → 본로이 카자흐어 대응이 차별화 여지. (시행계획 p20-48)

E. 리스크

- 비자 병목: 중증환자+동반자 비자가 "명확한 사유 없이 거절·지연 다수"(정부도 한계로 명시) → 환자에게 비자 확약 금지. 동시에 이 병목 해소가 본로이 가치제안이 될 수 있음. (시행계획 p22)
- 항공 리스크: 한-러 직항(모스크바) 전쟁으로 중단, 카자흐/우즈벡은 운항 → 러시아=원격협진 우선, 카자흐/우즈벡=실물 유치 우선의 전략 분기. (07 p35-297)
- 정산 리스크: 수수료 실태조사('26 하반기) + ⑤사업 회계 관리감독 강화. (통합고시 개정·시행계획 p67)
- 세그먼트 난이도: 유치업 평균은 의원·경증 79.7% 쏠림 — 본로이가 상급종합·암으로 가면 차별화되나 실행 난이도 ↑. (06 표4.6 p149)
- 부가세: 미용·성형 부가세 환급 특례 2025말 종료(암 진료는 원래 대상 아님, 간접 영향). (기재부 세제개편)

F. 등록·의무·개인정보 — 지금 지켜야 할 것 (법률·시행령·시행규칙·개인정보 안내서 정독)

- ① 개인정보 국외이전(개인정보보호법 제28조의8) = HEALO 최우선 리스크. 해외 에이전시에 여권·진단서 넘기는 것 = 국외이전(원칙 금지). 근거는 ③환자 별도 동의(이전 항목·국가·받는 자·목적·보유기간·거부방법 사전 고지, 다국어 동의서) 또는 ⑥계약이행 처리위탁(위탁계약서 필수 기재+처리방침에 국외이전 공개) 택1. 진단서=민감·여권=고유식별 → 1건 유출도 72시간 내 보호위/KISA 신고. 위반 시 매출 3% 과징금. [적용: 개인정보·계약·리스크]
- ② 실적보고(법 제11조) = 매년 2월 말 시·도지사 보고. 본로이 첫 보고 = 2027년 2월 말(2026 실적). 미보고=500만원 과태료→등록취소. ★ KHIDI 중간평가의 유치·상담·사후관리 건수가 곧 이 실적보고 데이터 → /admin/khidi/conversion 자동집계를 실적보고에 그대로 재사용(일석이조). [적용: 등록실무·중간평가]
- ③보증보험+등록 갱신. 보증보험 1억↑·기간 1년↑ 매년 갱신(끊기면 등록미달), 등록 유효 3년·갱신 만료 2개월전~20일전. 본로이 SGI(~2027-02-26)·등록(~2029-03-10) 두 날짜 캘린더 알람. [적용: 등록실무·리스크]
- ④명의대여 금지(법 제7조, 1년/1천만원). test 에이전시 계정으로 실환자 접수(#37 등) 지속 = 명의 문제 소지 → 정식계정 발급·이관 서두를 것. [적용: 법무·리스크]
- ⑤수수료 상한(제9조)+의료광고(제15조). 수수료 상한(의원 30%·병원/종합 20%·상급종합 15%) 초과 금지. 외국인환자 유치용 국내 의료광고는 원칙 금지(공항·면세점 등에서 외국어 표기만 허용) → HEALO 국내향 온라인 유치광고는 법무검토(해외 대상 광고는 상대적 안전). [적용: 계약·광고 컴플라이언스]
- 벌칙 서열: 미등록유치 3년/3천만(제28조·본로이는 등록완료로 회피) > 명의대여·광고위반 1년/1천만 > 실적미보고 500만 과태료.

근거 원문: 법률·시행령·시행규칙 전문(01-08 폴더, 재다운로드 완료) + 개인정보 적용안내서(06). 자본금 정확액·별지 서식번호 등 세부는 온전본 재검증 권장.